

ЗАГРОЗА РОЗРИВУ ПО РУБЦЮ

Сценарій.

Ви лікар акушер - гінеколог. До вас на прийом звернулася вагітна жінка 32 років. Вагітність III, 37 тижнів. Пологи II. Скарги на болі внизу живота
В анамнезі 1 штучний аборт, 1 пологи шляхом кесаревого розтину.
Менструальна функція до вагітності не порушена. Загальний стан задовільний. Положення плода повздовжнє. Спинка плода ліворуч і кпереду, передлежить голівка плода. ЧСС плода 140 уд/хв. При пальпації живіт болючий у ділянці післяопераційного рубця. Виділення зі статевих шляхів слизові. При УЗД виявлено – товщина післяопераційного рубця – 1,5 мм. Визначити результат клінічного аналізу крові, сечі та ультразвукового дослідження. Встановити провідний синдром, попередній діагноз і визначити подальший шлях пацієнтки. Розробити заходи щодо профілактики здорового способу життя та врахувати легальні й етичні аспекти ведення пацієнтки.

Клінічний аналіз крові

Показник	Значення
Гемоглобін (г/л)	130
еритроцити ($10^{12}/л$)	3,7
Кольоровий показник	0,89
Тромбоцити ($10^9/л$)	235,5
ШЗЕ (мм/год)	20
Лейкоцити ($10^9/л$)	5,3
Лімфоцити %	20
Еозинофіли %	0
Паличкоядерні нейтрофіли %	6
Сегментоядерні нейтрофіли %	71
Моноцити %	3

Клінічний аналіз сечі

Показник	Значення
Кількість	80 мл
Колір	Світло-жовтий
Прозорість	прозора
Питома вага	1,007
Білок	немає
Цукор	немає
Мікроскопія сечового осаду	
Лейкоцити	5-7 у п/з
Еритроцити	1-2 екз у п/з

Циліндри гіалінові	немає
Солі	немає
Слиз	немає
Бактерії	немає

Ультразвукове дослідження вагітності



Алгоритм виконання практичних навичок та вирішення клінічних кейсів

Алгоритм виконання		Форма представлення
1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Привітання з пацієнткою, встановлення контакту.	Сказати Доброго дня. Я лікар акушер-гінеколог.Моє ім'я
1.2	Отримання інформаційної згоди на проведення клінічного дослідження	Сказати Ви даєте свою згоду на проведення клінічного дослідження? (Будемо вважати що згода отримана)
1.3	Обробити руки на гігієнічному рівні та вдягнути захисну маску і рукавиці.	Сказати Будемо вважати, що руки оброблені
2. Збір скарг та анамнезу		
2.1	Скарги пацієнтки	Сказати: «Які у вас скарги?» Очікуваний відповідь: «Біль унизу живота.»
2.2	Акушерський анамнез	Сказати: «Як закінчились попередні вагітності?» Очікувана відповідь: «1 штучний аборт, 1 пологи шляхом кесаревого розтину»

2.3	Менструальна функція	Сказати: «Чи були порушення менструального циклу до вагітності?» Очікувана відповідь: «Ні»
3.Об'єктивне обстеження		
3.1	Загальний стан.	Сказати: Стан задовільний

3.2	Акушерське обстеження	Сказати: <i>Положення плода повздожне. Спинка плода ліворуч і кпереди, передлежить голівка плода. ЧСС плода 140 уд/хв. При пальпації живіт болючий у ділянці післяопераційного рубця.</i>
3.3	Піхвове дослідження	Сказати: <i>виділення зі статевих шляхів слизові.</i>
3.4	Уточнити у пацієнтки її самопочуття.	Сказати « <i>Як Ви себе почуваєте?»</i> Очікувана відповідь: <i>добре</i>
4. Діагностика		
4.1	Визначити <i>результат клінічного аналізу крові</i>	Сказати: <i>норма</i>
4.2	Визначити <i>результат клінічного аналізу сечі</i>	Сказати <i>норма</i>
4.3	Визначити <i>результат ультразвукового дослідження</i>	Сказати- <i>плід відповідає терміну вагітності товщина післяопераційного рубця – 1,5 мм.</i>
4.4	Визначити <i>провідний синдром</i>	Сказати- <i>больовий</i>
4.5	Встановити <i>клінічний діагноз</i>	Сказати : <i>Вагітність 37 тижнів. І позиція, передній вид, головне передлежання, рубець на матці після кесаревого розтину. Загроза розриву матки по рубцю.</i>
9. Визначення тактики ведення та лікування		
5	Призначити подальшу тактику ведення вагітної	Сказати : <i>госпіталізація у стаціонар для вирішення питання щодо планового кесаревого розтину.</i>
10. Профілактика та пропаганда здорового способу життя		
6	Рекомендувати профілактичні заходи	Сказати : <i>Уникнення фізичних навантажень, які можуть спровокувати підвищений тонус матки.</i>
7. Інше (в т.ч. легальні та етичні аспекти)		

7	Інформування пацієнтки про можливі ризики та етичні аспекти	<i>Ви повинні знати про можливі ризики, які можуть виникнути при вашому стані.</i> <i>У вашому випадку можливий розрив матки по рубцю.</i> <i>Це може призвести до гіпоксії плода, що може призвести до загибелі плоду.</i>
---	---	--